

ENTENDIENDO LA DEPRESIÓN

La depresión no siempre se ve. Hay personas que continúan con su vida y no expresan su dolor, pero hay otras que se enfrentan a síntomas que les impiden incluso levantarse de la cama. Cada caso es único y no podemos comparar ni invalidar.

Si tu ser querido es diagnosticado, debes prestar atención y animarlo a iniciar un tratamiento. No dejar avanzar la enfermedad.

La depresión no es un duelo. No es una semana mala. No es un mal día. Es algo mucho más serio. De hecho, el DSM-5 —el manual diagnóstico de referencia en psiquiatría— eliminó en 2013 la exclusión por duelo para el diagnóstico de depresión mayor, reconociendo que una pérdida puede desencadenar el mismo cuadro clínico.

No debemos autodiagnosticar a nadie y mucho menos a nosotros mismos. Si evidenciamos cambios en nuestra salud, debemos acudir a recibir atención médica.

Podemos prevenir el suicidio desde la infancia. Una crianza respetuosa y amorosa, el ejemplo de la inteligencia emocional en casa, son la base. Estudios han demostrado que los estilos de crianza con comunicación abierta, afecto y normas claras reducen significativamente el riesgo de depresión e ideación suicida en niños y adolescentes. Debemos evitar al máximo causar traumas que los obliguen a pasar la vida tratando de sanar una herida emocional. Enseñarles a expresar lo que sienten sin miedo, generar confianza, responder con amor, respetar sus silencios y no invadir su privacidad a menos que creamos que están en peligro.

En la niñez y adolescencia existen casos de suicidio que van en aumento alarmante, es muy importante vigilar sin invadir, permitir que se expresen y escucharlos con compasión, entendiendo que atraviesan cambios hormonales y de personalidad. Pero no podemos dar por sentado que su estado de ánimo bajo es simplemente por estar atravesando la etapa de la adolescencia. Es necesario que, si evidenciamos cambios de comportamiento o señales de alarma, acudamos a profesionales de salud mental.

Acompañar desde el amor y la empatía es fundamental. Es importante observar en nuestro entorno y estar dispuestos a brindar compañía y contención en una crisis. Pero prevenir también es evitar espacios tóxicos, ya sea en el ambiente escolar, laboral o comunitario. Denunciar el acoso, la violencia, la discriminación, el bullying. Utilizar un lenguaje respetuoso.

Es clave tener claro que una ruptura, perder un trabajo o enfrentar cualquier situación difícil puede detonar una crisis. Pero si la persona reacciona con ideación suicida frente a un desafío, no es débil. Eso es simplemente un detonante. Seguramente viene luchando contra sus pensamientos y emociones desde mucho antes. Eso es lo peligroso de guardar silencio y no pedir ayuda.

Por eso es de suma importancia que, cuando alguien nos expresa sus emociones y pensamientos, no juzguemos ni minimicemos. El desenlace, a corto o largo plazo, puede ser mortal.

Hay que derribar mitos.

La depresión no es estar poseído por un demonio, y la espiritualidad no cura la depresión. No hay casos documentados de sanidad por oraciones. Aunque la intención sea buena, suena a que no se le da la importancia suficiente a la persona que decide romper su silencio. Por el contrario, hay casos confirmados de personas que salen de la depresión gracias a un tratamiento y al acompañamiento de su red de apoyo.

La evidencia científica muestra que el tratamiento combinado (farmacológico + psicoterapia) es más eficaz que cualquiera de las modalidades aisladas. Un estudio clínico con casi 600 pacientes mostró que el 47% alcanzó una remisión estable durante el seguimiento, y 183 de ellos lo lograron durante el primer año. En otro estudio, el 79.9% experimentó mejoría en sus síntomas con antidepresivos ISRS, y el 45.8% logró la remisión total. Sin embargo, los resultados varían: en ensayos clínicos controlados solo el 35% alcanza la remisión con el primer antidepresivo, mientras que en la práctica clínica real la efectividad reportada es menor.

Es importante recordar que cada caso es único y nada garantiza que lo que funciona para una persona funcione para otra. Lo que a unos les da resultado, a otros puede no servirles. Pero siempre vale la pena intentar todo lo que esté al alcance: buscar ayuda profesional, explorar opciones terapéuticas, construir una red de apoyo, y no rendirse al acompañar a quien sufre. La recuperación es posible, y muchas personas han logrado salir adelante después de encontrar el tratamiento adecuado para ellas. Pero también hay casos donde la persona no logra una recuperación aunque intente varias salidas. Hay que ser empáticos y compasivos.

Cuando una persona se suicida, no fue cobarde ni valiente. Fue alguien que ya no pudo soportar el dolor y quiso terminar su sufrimiento. No debemos juzgar ni criticar a sus seres queridos; debemos rodear de amor y compasión a quienes pierden a alguien por suicidio, y también respetar la memoria de quien libró una batalla difícil por su vida. Menos preguntas y más abrazos.

Tampoco es cierto que la medicina sea peligrosa, siempre y cuando se lleve a cabo bajo la vigilancia de profesionales de salud mental. No es cierto que la depresión sea algo a lo que no debemos prestar atención: es como cualquier otra enfermedad, donde la persona está en riesgo de muerte.

No es cierto que una persona que manifiesta el deseo de suicidarse no lo va a hacer. Las estadísticas lo desmienten: la OMS señala que el intento previo de suicidio es el principal predictor de un nuevo intento. Hay que activar la ruta de atención. Tampoco es cierto que alguien que intenta suicidarse no lo va a volver hacer. Si una persona intenta el suicidio, se debe redoblar el acompañamiento y la vigilancia.

Existen varios mitos que solo entorpecen la ardua tarea de la prevención. Es necesario informarnos y cambiar las narrativas que utilizamos frente a esta situación, y empezar a ser de ayuda. Si bien es cierto que un entorno hostil y desigual acentúa el deterioro, podemos organizarnos como sociedad para ser una red de apoyo integral y, entre todos, salvar vidas.

Si quieres unirte a nuestra red de apoyo consulta el enlace: **RED DE APOYO INTEGRAL**